

נוהל מס': 027.15
שם הנוהל: לידה מחוץ לביה"ח
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: פברואר 2015 מהדורה: תאריך עדכון:
	שם הנוהל: לידות בית		
	כותב הנוהל:דר' עדי הלברטל, דר' מיה שטינברג		נספחים:
	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 6			

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

2	1. רקע
3	2. מטרות הנוהל
3	3. הגדרות ומונחים
3	4. סמכות ואחריות
3-5	5. עקרונות הנוהל
6	6. סימוכין (אסמכתאות)

1. רקע:

לידות מחוץ לבית החולים בישראל מתחלקות לשלש קבוצות:

1. לידות בית מתוכננות בעזרת מיילדת או רופא מיילד (planned home birth)

– בישראל מתבצעות מאות לידות בית מתוכננות בשנה. חלק מהילדות מועברות לבית החולים טרום הלידה וחלקן לאחר הלידה. חלק מגיעות מספר שעות לאחר הלידה לבית החולים ומתאשפזות לצורך רישום וקבלת מענק לידה. יש לציין כי הנתונים היחידים שפורסמו בישראל לגבי לידות בית מתוכננות הם מעבודתו של אבנר שיפטן (1) בה פורסם מידע לגבי לידות בית מתוכננות בישראל בין השנים 2003-2007, כאשר כל המידע בעבודה זו מבוסס על שאלונים שנשלחו למיילדות בית או רופאים מיילדים בבית, ולא מתוך גליונות רפואיים מבתי חולים מוכרים. לפי עבודה זו בשנים הנ"ל התקיימו 1,749 לידות בית מתוכננות, כ 0.3% מסך הלידות בישראל. כ 9% הועברו לבית החולים טרום הלידה, 2.2% מהילדות ו 1.2% מהילודים הועברו לבית החולים לאחר הלידה. נתונים ממדינות מערביות מדווחים על אחוז מעבר לבית החולים טרום הלידה של כ 4-9% בוולדניות וכ 30% במבכירות. (2,3)

הסיבות השכיחות להעברת יולדת מלידת בית לבית החולים הן חוסר התקדמות בלידה, NRFHR, צורך באנלגטיקה, יל"ד, דימום מוגבר ומצג פתולוגי. הסיבות העיקריות להעברת יולדת לאחר השלב השני של הלידה הן צורך בהוצאת שלייה שלא יצאה בשלמותה או לצורך תפירת קרעים (1,2) חשוב לציין, שמשדד הבריאות מדגיש כי לידות בחדרי לידה מוכרים ומורשים, הן בטוחות יותר ליולדת וליילוד וכי יולדת המעוניינת בלידת בית חייבת לעמוד בתנאים הכרחיים לביצוע לידת בית המפורטים בחוזר מינהל הרפואה מס' 17/2012 (4)

2. לידות מקריות מחוץ לבית החולים (accidental out of hospital deliveries)

– בלידות אלו התוצאות המיילדותיות גרועות בהרבה מאשר בלידות בבית החולים. באוכלוסיות מסוימות בישראל, כגון אוכל' הבדווים בנגב, שכיחות לידות אלו גבוהה יחסית ומגיעה עד 2% מלידות החי. (5)

3. לידות בית מתוכננות ללא עזרת מיילדת או רופא – מסיבות סוציאליות או מתוך תפישת עולם בקהילות מסוימות. זוהי קבוצה קטנה ביותר.

נוהל מס': 027.15
שם הנוהל: לידה מחוץ לבית"ח
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



2. מטרת הנוהל:

להגדיר את הפעולות אותן יש לבצע עם קבלת יולדת לאחר כל לידה מחוץ לבית החולים.

3. הגדרות ומונחים:

"לידת בית" – לידה בבית היולדת, לאחר תכנון והכנה מראש ומתוך בחירה של היולדת.
"לידה מקרית מחוץ לבית החולים" – לידה שהחלה מחוץ לבית החולים ללא כוונה מראש.

4. סמכות ואחריות:

הטיפול ביולדת הינו באחריות רופא בכיר/אחראי תורנות. הטיפול ביילוד הינו באחריות מח' היילודים בהתאם לנהלים שלהם.

5. עקרונות הנוהל:

א. קבלת יולדת:

- ✓ בקבלת יולדת ויילוד מכל לידה שהחלה/התרחשה מחוץ לבית החולים יבוצע הליך אשפוז כמקובל בחדר לידה. יש לבצע קבלה רפואית וסיעודית מלאה.
- ✓ יש למלא אבחנה "planned home delivery" או "accidental out of hospital delivery" (או למלא בהערות של האבחנה הראשית במידה ולא נמצאה אחת מהאבחנות הנ"ל) ולציין זאת גם בסעיף "הערות לרופאי היילודים".
- ✓ במידה והיולדת החלה לידת בית מתוכננת, העתק של טופס רישום מהלך הלידה יצורף לגיליון הרפואי.

ב. טיפול ביולדת:

I. היולדת והיילוד יעברו בדיקה גופנית והמשך טיפול בהתאם לנהלים הקיימים.

II. חיסון לטטנוס (פלצת):(6)

לפי נוהל משרד הבריאות "מניעת פלצת ביילוד וביולדת לאחר חשיפה" חשיפת יולדת וילוד לזיהום אפשרי של טטנוס עקב "לידה ללא השגחה מילדותית מתאימה" (באתרים ובמצבים חריגים כגון: לידת בית, לידת שדה,

לידה בשירותים וכו') מוגדרת כ "פציעה אחרת" לצורך מתן טיפול מונע נגד טטנוס ומחייבת התיחסות בהתאם לטבלה הבאה:

מצב החיסון של היולדת	תכנית טיפולית ביולדת	תוכנית טיפולית בילוד
חיסון פעיל מלא בעבר, חלפו פחות מ-5 שנים ממועד מתן המנה האחרונה.	אין צורך במתן חיסון	לשקול מתן TIG לפי נסיבות אפידמיולוגיות פרטניות* חיסון פעיל נגד טטנוס לפי שגרת החיסונים
חיסון פעיל מלא בעבר, חלפו יותר מ-5 שנים ממועד מתן המנה האחרונה	חיסון דחף Td	TIG ובהמשך חיסון פעיל נגד טטנוס לפי שגרת החיסונים.
לא ידוע או לא קיבלה בעבר בכלל, או קיבלה בעבר פחות מ-3 מנות חיסון נגד טטנוס	Td+TIG והשלמת סדרת חיסון פעיל מלאה	TIG ובהמשך חיסון פעיל נגד טטנוס לפי שגרת החיסונים.

*צורך במתן חיסון סביל (TIG) לילוד יקבע בהתאם לסבירות ההדבקה בטטנוס. ההחלטה תתבסס על נתונים אפידמיולוגיים כגון סוג החשיפה. לדוגמה: חשיפה ישירה של חבל הטבור לבוץ מהווה הוריה למתן TIG לתינוק על אף שהאם מחוסנת בחיסון פעיל מלא וחלפו פחות מ-5 שנים ממועד מתן המנה האחרונה.

III. טיפול אנטיביוטי פרופילקטי:

למרות שלא קיימים סימוכין/הנחיות בספרות או בנהלים המפורסמים במשרד הבריאות לגבי מתן אנטיביוטיקה מניעתית, היו תיאורי מקרים של מטריטיס ואלח דם לאחר לידות מחוץ לבית החולים ועל כן המלצתנו היא לתת טיפול.

היולדת תקבל מנה אחת של צפמיזין 1 גרם תוך ורידי. במקרים של רגישות לצפלוספורינים או רגישות קשה לפניצילין היולדת תקבל קלינדמיצין 900 מ"ג תוך ורידי.

IV. בסיום הליך הקבלה והבדיקה יומלץ ליולדת אשפוז. אם תסרב, תשוחרר ע"י רופא אחראי תורנות.

נוהל מס': 027.15
שם הנוהל: לידה מחוץ לביה"ח
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



ג. אישור אימהות לצורך רישום ילודים במרשם האוכלוסין:

- I. לידה בה טיפלו רופא או מיילדת מוסמכת – אישור יינתן ע"י הנוכח בלידה, באחריות היולדת לוודא המסמכים הנדרשים.
- II. לידה שלא טיפלו בה רופא או מיילדת – יש לפעול לפי הנחיית חוזר מנהל הרפואה חוזר מס' 3/2006, סעיף ב.4.

(א) על היולדת להיבדק בתוך 48 שעות על ידי רופא מומחה ביולוד וגינקולוגיה או מתמחה ביולוד וגינקולוגיה במוסד רפואי מוכר בפיקוחו של מומחה כאמור, והוא ייתן ליולדת תעודת רופא בדבר היותה אמו הטבעית של היולוד –

(1) לשם מתן אישור כאמור על הרופא לקבל אנמנזה מפורטת וכן לבצע בדיקה גופנית של היולדת, ובדיקות עזר נוספות כפי שיראה לנכון.

(2) סירבה היולדת להיבדק – על הרופא להסביר לה כי ללא בדיקה לא יוכל לתת בידה את האישור הנחוץ לשם רישום היולוד במשרד הפנים.

(3) במידה ולפי הבדיקה לא ניתן לקבוע כי הנברקת עברה לידה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקה – אין לתת את האישור. במקרה זה יש להפנות את היולדת למשרד הפנים לשם קבלת הנחיות לעניין ביצוע בדיקה גנטית להורות לאם וליולוד.

(ב) יש לציין כי בנוסף לתעודת הרופא האמורה על היולדת להצטייד, לצורך רישום היולוד במשרד הפנים, באישור על מעקב הריון שנערך משבוע 28 ואילך (ראה סעיף 4 להלן), וכן תצהיר מטעמה בדבר היותה אמו הטבעית של היולוד.

- III. יולדת שפונתה באמבולנס לבית חולים וילדה באמבולנס, תיחשב כיולדת שילדה במוסד הרפואי אליו פונתה.

נוהל מס': 027.15
שם הנוהל: לידה מחוץ לביה"ח
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



6. סימוכין:

1. תוצאות של לידות בית מתוכננות בישראל בין השנים 2003-2007. שיפטן, א, תל אורן ע., שיינר א, הדר א. הרפואה 148 יוני 2009 362-366.
2. Planned home birth. ACOG Committee Opinion 476, February 2011
3. Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011;343:d7400 doi.
4. חוזר מנהל הרפואה מס' 17/2012 "לידות בית" (נספח 1)
5. Sheiner E, Shoham-Vardi I, Hadar A & al, Accidental out of hospital delivery as an independent risk factor for perinatal mortality. J Reprod Med, 2002;47:625-30
6. חוזר מנהל הרפואה מס' 21/2000 "מניעת פלצת ביילוד וביולדת לאחר חשיפה" (נספח 2)
7. חוזר מנהל הרפואה מס' 24/2008 " אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין" (נספח 3)